جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : رانيا سيد نبوي ابراهيم
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** اخري **العنوان :** مجاوره 8
رقم البطاقة : 27607260100169 **رقم التليفون :** 01009499224 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 26-07-1976 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: رانيا سيد نبوي ابراهيم
National ID: 27607260100169

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE.ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	:الأستاذه / رانيا سيد نبوى ابراهيم	Request No.	: 13006579
Patient No.	: 27607260100169	Request Date	: 22/05/2023
Path No.	: 3831/22	Verification Date	: 04/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast cancer, post NACT.

Nature of the specimen: Right BCS and Axillary lymph node dissection.

Gross Examination: Four specimens were received:
1- Fibrofatty tissue piece measured 9x8cm, not covered by skin.Cut section revealed an ill defined grayish white glistening ruberry tissue measured 4x4x2cm admixed with fat; just below superior margin grossly.
2- Another fibrofatty tissue piece (extralateral margin) measured 5x4cm, No gross induration.
3- Also received another fibrofatty tissue piece with clipped area measured 4x3cm. Cut section revealed clip guided grayish white ruberry tumour bed site measured 1.3x1.3cm.
4- Axilla: Fibrofatty tissue piece measured 11x10x2cm enclosing 14 lymph nodes up to 3x1cm.
- Frozen section: Free margins and free extramargin.
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5).
Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma (20% cellularity).
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GIII (3+3+2).
- Ductal carcinoma in situ: Positive DCIS (micropapillary pattern).
- Two lymph nodes showed isolated tumour cells and one lymph node showed micrometastasis. No macrometastasis deposits was detected.
- Resection Margins: Free margins and free extramargin.
- Histologic response to therapy: Partial pathological response.
- IPT:

ER: No nuclear reaction intumor cells (Allred score 0/8)

Verified by :

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: رانيا سيد نبوي	
MR. : 7096	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with triple-negative breast cancer in January 2023 and was discussed at multidisciplinary tumor board (MDT). The treatment plan at that time included adjuvant radiotherapy (PORT) and capecitabine (Xeloda). A computed tomography (CT) of the chest, abdomen, and pelvis was ordered for baseline evaluation.

A dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) scan demonstrated osteopenia. The patient received zoledronic acid (Zometa) on the same day, and laboratory studies performed on 27 April were reviewed and accepted.

In June 2026 a CT scan raised concern for possible metastatic disease involving the lungs, liver, and bone. A PET-CT was requested for further assessment. The patient has a history of hormone-free lifestyle (hfl) since 2022.

The same concerns regarding suspected lung, liver, and bone metastases were reiterated in a repeat entry on the same day, with the PET-CT still pending.

The patient is a 50-year-old with a history of invasive ductal carcinoma (IDC) grade III of the right breast. Immunohistochemistry showed ER 0/6, PR 0/8, HER2-negative, and Ki-67 10 %. Pathology staged the disease as cT3 N3 M0. Following neoadjuvant chemotherapy (4 cycles of AC followed by 12 weeks of taxane-containing therapy), the patient underwent breast-conserving surgery (BCS) with axillary lymph node dissection. Final pathology revealed IDC grade II with positive DCIS, clear surgical margins, and a pathological complete response (pCR) in the nodes (N1mi). Post-operative management included capecitabine (Xeloda) and radiotherapy (PORT). The patient has been under follow-up since then, and the most recent CT report is pending further review.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

Patient Name	: الأسكندر / رانيا سيد نبوى ابراهيم	Request No.	: 13006579
Patient No.	: 27607260100169	Request Date	: 22/05/2023
Path No.	: 3831/22	Verification Date	: 04/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورلم دار السلام - مهاره
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

PR: No nuclear reaction intumor cells (Allred score 0/8)
Her-2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)

Diagnosis:
Right breast cancer; Right BCS and Axillary lymph node dissection:
- Invasive duct carcinoma GIII (20% cellularity) with positive DCIS (micropapillary pattern).
- Two lymph nodes showed isolated tumour cells and one lymph node showed micrometastasis. No macrometastasis deposits was detected.
- Free margins and extramargin.
- Partial pathological response to therapy.
- Stage: ypT1b.
- IPT:

ER: Negative (score 0/8).
PR: Negative (score 0/8).
HER-2: Negative (score 0).

Dr.Esraa Megdy

Prof. Gamal Abdellatty.
Dr. Marwa Mahmoud.

Verified by :
dr.esraa magdy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Date: 20-12-2025

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Post Right CBS

Findings:

Right breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- UOQ, architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry, or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated UOQ area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid, cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- Normal nipple/areola complex.
- Clear right axilla.

Left breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Few benign looking axillary lymph nodes with preserved oval shape and central echogenic hilum

Conclusion: -

Right breast (BIRADS 2): Post-operative sequalae.

Left breast (BIRADS 1): Normal study.

Dr farah elshobaky

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

Name : Rania Sayed Nabawy Ibrahim
Branch : Portable
Ref.Physician Prof :

Date : 16-12-2025 10:13
Medical No. : GRI-12844
Ins.Company :

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

I- CHEST:

- Small right middle lobe pneumatocele.
- No pulmonary nodules or masses.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

- **Small right middle lobe pneumatocele.**
- **No pulmonary nodules, hepatic focal lesions or worrisome bone lesions.**

Dr. Sherif Wagdy

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

A-Patient ID:
1- Name : رانيا سيد نبوى ابراهيم
2-ID number: 27607260100169

Sex: Female

MDT form

3- Medical number: 83074685
Old Med : 1682/2022

Patient Age : 47 Y

MDT

Family history
marital status
Co morbidity APPPENDECTOMY

Phone 01009499224
NRS Score
marital status

BMI
GROUP
premenopausal Menopausal status

REASON OF MDT
Date of MDT 01/11/2023 ~~01/11/2023~~ 12/11/23

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
BONE SCANS/2022-->FREE

BX:	IHC:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	KI67 :
RT IDC GIII 4/22		0/8	0/8	-ve	10

T	N	N
CT3	3	0

Sonomammography
4/22-->RT BREAST LESION WITH RT AXILLARY LNS

Recommendations:
pathology report 2/1/2023-->RT BCS AND AXILLLARY LN DISSECTION POST NACT (4AC+ 12 WK TC),,,IDC GIII (20% CELLULARITY) WITH +VE DCIS
TWO LYMPH NODES SHOWED ISOLATED TUMOR CELLS AND ONE LN SHOWED MICROMETS
NO MICROMETS DEPOSITS WAS DETECTED,,,FREE MARGINS,,PPR,,,STAGE YPT1B N1 mic

MDT OUTCOME & PLAN

FOR
adjuvant xeloda for 6ms
PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ جيل	RADIOLOGY	د/ ناهد
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

boul.blank

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]